

■ 心臓リハビリテーション／Cochrane

心臓リハビリの運動療法、Cochrane更新版が予後改善を裏付け

107試験・2.7万人を統合、心筋梗塞は28%減 全死亡はわずかな可能性にとどまる

冠動脈疾患(CHD)患者への運動療法主体の心臓リハビリテーションについて、Cochraneの系統的レビューが2026年3月時点まで検索を更新。新規22試験を含む計107試験・26,886人分のRCTを統合し、この分野で最大級のエビデンス集積となった。

短期(6～12ヶ月)で心筋梗塞が28%減少(リスク比0.72、95%CI 0.54-0.95、高確実性)、全死因入院は35%減少(リスク比0.65、95%CI 0.51-0.82、中確実性)。全死因死亡率は「わずかに減る可能性」にとどまり(リスク比0.86、95%CI 0.74-1.00)、信頼区間の上限が1.00に触れ、はっ

きり有意とは言い切れない水準。QOLの改善は12ヶ月まで一貫して確認された。

女性の参加は全体の17%にとどまり、低中所得国の試験は26件中11件が今回の更新分。効果は明確でも、誰にどれだけ届いているかは今後の課題として残る。



エビデンスは最大級、届き方の格差は次の課題

出典 **Cochrane Database Syst Rev** ↗

数字で見る

107 試験

統合したRCT(2.7万人)

28%減

心筋梗塞リスク(高確実性)

17%

参加者に占める女性の割合

■ 脳卒中／痙縮治療

体外衝撃波療法を追加、慢性期脳卒中の痙縮が有意改善

単盲検シャム対照RCT。rESWT追加群(n=43)は痙縮(Modified Ashworth Scale)が有意改善(群間差-0.56、p<0.001)、中央値は2点から1点へ低下。対照群(n=42)は変化なし。

10m歩行は1.41秒、Timed Up and Goは2.46秒短縮し、下肢運動機能・QOLも有意に上乘せ改善(いずれもp<0.001)。



有害事象はなし。効果は4週間後の短期評価まで、長期の効果・安全性は今後の検証待ち。

出典 **NeuroRehabilitation** ↗

■ 医療AI／整形外科リハ

膝置換術後リハ、AIが「非応答」患者を外部検証で識別

訓練2,313人・外部検証用テスト3,150人、計5,463人のデータで自動機械学習(AutoGluon)モデルを構築。膝関節全置換術後のリハで臨床的に意味のある改善(MCID)に届かない「非応答」患者を予測する。

外部検証での識別性能はTUGでAUC0.771、EQ-5D-IndexでAUC0.770、WOMACでAUC0.704。入院時点の



身体機能が良いほど非応答になりやすいという一見逆説的な傾向が示され、天井効果の可能性も指摘される。

出典 **Frontiers in Rehabilitation Sciences** ↗

短 信

〈心不全〉心不全のADL低下、SPPBで予測

417人の前向き研究。SPPB低値がHAD発症と関連(AUC0.811・カットオフ6.5点) 出典 [Phys Ther](#) ↗

〈透析〉透析患者への下肢NMES、効果は不明瞭

Cochrane新規レビュー(12RCT・299人)。血圧等への効果差はほぼ無くエビデンスの確実性は低い 出典 [Cochrane Database Syst Rev](#) ↗

〈医療AI〉転倒予防のXR×AI、エビデンスなお細い

ラピッドレビューで該当研究わずか4件。転倒発生を直接測った研究はゼロ 出典 [NeuroRehabilitation](#) ↗

〈整形外科〉大腿骨骨折の早期荷重、国際合意まとまる

31名15カ国のデルファイ合意。低導入地域向けに13の推奨を提示 出典 [J Bone Joint Surg Am](#) ↗

〈作業療法〉脳卒中後の疲労と作業バランス、関連は不明瞭

192人の研究。解析手法で結果が割れ、回帰モデルも非有意(R2=.018) 出典 [Appl Neuropsychol Adult](#) ↗

〈生活期リハ〉通所リハに座位有酸素運動、フレイル改善

広島大、6か月介入で2分間ステップ+19.4回。非ランダム化の限界あり 出典 [PubMed\(通所リハ二次解析\)](#) ↗

〈疼痛管理〉骨粗鬆症関連骨折、疼痛が在院日数を左右

回復期114人。退院時疼痛が在院日数と直接関連(標準化係数0.56) 出典 [総合理学療法学](#) ↗

〈呼吸リハ〉コロナ後の外来呼吸リハ、歩行距離+74.67m

54人が完了(非ランダム化)。6週間で6分間歩行・呼吸困難・疲労とも改善 出典 [Frontiers in Rehabilitation Sciences](#) ↗